BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

ASM Hizmetleri ve Demografik Veriler

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği · ASM'nin Hizmetleri · Aile Sağlığı Elemanının Görevleri · Nüfus Verileri · Sağlık Göstergeleri

FR.184 beceri 1 için: ASM'nin verdiği hizmetleri sayabilme ve hizmet verilen toplumun demografik özelliklerini toplayıp yorumlayarak anlatabilme.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – ASM Hizmetleri ve Demografik Veriler Çalışma Notu

1. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ

- 1.1 Sağlık hizmetlerinin basamakları
- 1.2 Temel sağlık hizmetleri anlayışı
- 1.3 Türkiye'de aile hekimliğine geçiş
- 1.4 Aile hekimliği sisteminin özellikleri

2. ASM'NİN VERDİĞİ HİZMETLER

- 2.1 Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler
- 2.2 İzlemler
- 2.3 Taramalar
- 2.4 Tanı, tedavi ve sevk hizmetleri
- 2.5 Hemşirelik uygulamaları
- 2.6 Ev ziyaretleri ve bakım hizmetleri
- 2.7 Kayıt, bildirim ve diğer hizmetler

3. AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ (HEMŞİRE/EBE) GÖREVLERİ

4. HİZMET VERİLEN TOPLUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

- 4.1 Hangi verileri toplamalısın?
- 4.2 Nüfus piramidi ve yorumlanması
- 4.3 Sağlık göstergeleri ve formülleri
- 4.4 Verileri nasıl sunarsın? – Örnek konuşma

5. ASM'NİN FİZİKİ YAPISI VE BİRİMLERİ

6. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – ASM Hizmetleri ve Demografik Veriler Çalışma Notu

Bu not, FR.184 İME Beceri Listesi'nin ilk becerisine hazırlanman için yazıldı:

> **Beceri 1:** "Bulunduğu kurumun hizmet verdiği toplumun **demografik özelliklerini açıklayabilmesi** (gebe, bebek, çocuk, ergen, yaşlı, kronik hastalıklı birey sayısı vb.), **ASM'nin verdiği hizmetleri sayabilmesi/açıklayabilmesi**."

Bu becerinin iki parçası var: **(1) ASM'nin hizmet verdiği nüfusu tanımak ve sayısal olarak anlatabilmek**, **(2) ASM'nin hangi hizmetleri verdiğini sayıp açıklayabilmek.** Uygulamanın **ilk haftasında** bu bilgileri toplaman ve değerlendirme sırasında ezbere anlatabilmen beklenir.

---

1. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ

1.1 Sağlık hizmetlerinin basamakları

- **Birinci basamak:** Toplumun sağlık sistemiyle ilk temas ettiği yerdir. Koruyucu hizmetler, sağlığın geliştirilmesi, sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisi, kronik hastalıkların izlemi ve gerektiğinde üst basamağa sevk burada yapılır. Kurumlar: **Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)**, ilçe sağlık müdürlükleri ve bunlara bağlı birimler (Toplum Sağlığı Merkezi hizmetleri), **KETEM** (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi), **Sağlıklı Hayat Merkezleri**, **Verem Savaş Dispanserleri**, **Göçmen Sağlığı Merkezleri**, **112 Acil Sağlık Hizmetleri**.
- **İkinci basamak:** Yataklı tanı ve tedavi hizmetleri; devlet hastaneleri ve özel hastaneler.
- **Üçüncü basamak:** İleri uzmanlık gerektiren tanı ve tedavi; eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri.

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlü olduğunda hastalıklar önlenir, erken yakalanır ve hastanelerin yükü azalır.

1.2 Temel sağlık hizmetleri anlayışı

- **Alma-Ata Bildirgesi (1978):** Dünya Sağlık Örgütü'nün "**2000 yılında herkes için sağlık**" hedefiyle temel sağlık hizmetlerini tanımladığı bildirgedir. İlkeleri: hakkaniyet (herkesin ihtiyacı kadar hizmet alması), toplum katılımı, sektörler arası işbirliği, uygun teknoloji kullanımı, koruyucu hizmetlere öncelik.
- **Astana Bildirgesi (2018):** Temel sağlık hizmetlerinin **evrensel sağlık kapsamının** temeli olduğunu yeniden vurgulamıştır.

1.3 Türkiye'de aile hekimliğine geçiş

- **224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1961):** Birinci basamakta **sağlık ocakları** ve sağlık evleri kuruldu; bölge tabanlı hizmet verildi.
- **Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003):** Birinci basamakta **aile hekimliği** modeline geçiş planlandı.
- Aile hekimliği önce **Düzce'de (2005)** pilot olarak başladı; **2010 yılında tüm Türkiye'de** uygulamaya geçildi.

1.4 Aile hekimliği sisteminin özellikleri

- Her vatandaş bir **aile hekimine kayıtlıdır**; kişiler belirli kurallar çerçevesinde aile hekimlerini değiştirebilir.
- Bir **aile hekimliği birimi**, bir aile hekimi ve en az bir **aile sağlığı elemanından (ASE)** oluşur.
- **Aile sağlığı elemanı** olarak **hemşire, ebe**, sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) ya da acil tıp teknisyeni çalışabilir.
- Birden fazla aile hekimliği biriminin aynı binada hizmet verdiği yere **Aile Sağlığı Merkezi (ASM)** denir.
- Her birime kayıtlı nüfus belirlidir; birim başına ortalama birkaç bin kişi kayıtlıdır (yaklaşık 3.000–4.000).
- Kayıtlı nüfusa yönelik **koruyucu hizmetler** (gebe, bebek, çocuk izlemleri, aşılar, taramalar) **performans ölçütleriyle** izlenir; bu nedenle izlem ve aşıların zamanında yapılması ve kaydedilmesi çok önemlidir.
- Hizmetlerin kaydı **Aile Hekimliği Bilgi Sistemi** yazılımları üzerinden yapılır ve **e-Nabız** ile Sağlık-Net'e aktarılır. Kronik hastalıkların taraması ve izlemi **Hastalık Yönetim Platformu (HYP)** üzerinden yürütülür.

---

2. ASM'NİN VERDİĞİ HİZMETLER

Değerlendirmede "ASM'nin verdiği hizmetleri sayar mısın?" sorusuna aşağıdaki gruplar halinde cevap verebilirsin. Ezber için gruplar: **Koruyucu hizmetler – İzlemler – Taramalar – Tanı-tedavi – Hemşirelik uygulamaları – Ev ve bakım hizmetleri – Kayıt ve diğerleri.**

2.1 Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler

- **Bağışıklama:** Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bebek ve çocuk aşıları, gebelere ve doğurganlık çağındaki kadınlara Td, risk gruplarına grip ve pnömokok aşıları; aşı takibi; **soğuk zincirin** sürdürülmesi; aşı reddi durumunda bilgilendirme.
- **Destek programları:** Bebeklere **D vitamini** (doğumdan 1 yaşın sonuna kadar) ve **demir** (4. aydan 12. ayın sonuna kadar); gebelere **demir** (16. haftadan doğum sonrası 3. ayın sonuna kadar), **D vitamini** (12. haftadan doğum sonrası 6. ayın sonuna kadar) ve **folik asit** desteği.
- **Üreme sağlığı ve aile planlaması:** Danışmanlık, yöntem uygulama (kondom, hap, iğne, rahim içi araç – ASM'nin olanaklarına göre), doğum sonu aile planlaması.
- **Sağlık eğitimi ve danışmanlık:** Emzirme, bebek bakımı, beslenme, fiziksel aktivite, sigara bırakma, kaza önleme, kronik hastalık yönetimi, kanser taramaları.
- **Bulaşıcı hastalıkların kontrolüne katkı:** Bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi, temaslıların izlenmesine katkı, salgın durumunda görev alma, tüberküloz hastalarının tedavisine destek.

2.2 İzlemler

- **Gebe izlemi:** Riskli olmayan gebeye en az 4 izlem (ilk 14 hafta, 18–24, 28–32, 36–38. haftalar); risk saptanırsa sevk.
- **Lohusa (doğum sonu) izlemi:** Doğumdan sonra 42 güne kadar.
- **Bebek izlemi:** İlk yılda en az 9 izlem.
- **Çocuk izlemi:** 1–6 yaş arasında 7 izlem (12, 18, 24, 30, 36, 48 ve 60. aylar).
- **Okul çağı ve ergen izlemi:** 6–19 yaş arasında yılda bir.
- **15–49 yaş kadın izlemi:** Üreme sağlığı, aile planlaması, Td, kansızlık, taramalar.
- **Erişkin ve kronik hastalık izlemi:** Hipertansiyon, diyabet, kalp-damar riski, obezite, KOAH, kronik böbrek hastalığı (HYP).
- **Yaşlı izlemi:** 65 yaş ve üzeri bireylerin kapsamlı değerlendirmesi.

2.3 Taramalar

- **Kanser taramaları:** Meme (40–69 yaş kadınlarda 2 yılda bir mamografi; klinik meme muayenesi; KKMM öğretimi), serviks (30–65 yaş kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testi/smear), kolorektal (50–70 yaş kadın ve erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan testi). ASM; hedef nüfusu belirler, davet eder, GGT kiti verir, HPV-smear örneği alır, mamografi için KETEM'e yönlendirir ve sonuçları takip eder.
- **Yenidoğan taramalarının takibi:** Topuk kanı sonuçları ve tekrar örnek gereksinimi, işitme taraması sonucu, kalça ultrasonu.
- **Kronik hastalık risk taramaları:** Kan basıncı, kan şekeri, kilo-bel çevresi, kalp-damar riski.
- **Büyüme-gelişme taramaları:** Persentil izlemi, gelişim değerlendirmesi, görme ve işitme değerlendirmesi, kansızlık taraması.

2.4 Tanı, tedavi ve sevk hizmetleri

- Poliklinik muayenesi, sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisi, **reçete** düzenleme, kronik hastalık ilaçlarının düzenlenmesi.
- **Laboratuvar** hizmetleri: kan ve idrar örneği alma (ya da yönlendirme), sonuçların takibi; hızlı testler (kan şekeri, hemoglobin, idrar şeridi).
- **Sevk:** Gerektiğinde ikinci ya da üçüncü basamağa yönlendirme ve geri bildirimin takibi.
- **Acil müdahale ve ilk yardım;** gerektiğinde 112 ile koordinasyon.

2.5 Hemşirelik uygulamaları

- Kas içi, deri altı ve deri içi **enjeksiyonlar**; **aşı** uygulaması.
- **Kan alma**, parmak ucu **kan şekeri** ölçümü, **topuk kanı** alma.
- **Pansuman**, sütür alma.
- **Kan basıncı** ölçümü, nebül uygulaması, EKG çekimi.
- Kanser tarama işlemleri (GGT kiti, HPV-smear).

2.6 Ev ziyaretleri ve bakım hizmetleri

- Yenidoğan ve lohusa ev ziyaretleri.
- Yaşlı, yatağa bağımlı, engelli bireylerin evde izlemi; gerektiğinde **Evde Sağlık Hizmetleri** birimiyle koordinasyon.
- Bağlı yerlere (köyler, huzurevi, cezaevi gibi kurumlar – bölgeye göre) **gezici sağlık hizmeti**.

2.7 Kayıt, bildirim ve diğer hizmetler

- Tüm hizmetlerin **kaydı** ve e-Nabız'a aktarılması.
- **Doğum ve ölüm bildirimleri**; bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi.
- **Sağlık raporları** (mevzuatın izin verdiği durumlarda: sürücü, iş, okul, spor vb.).
- **Afet ve salgın** dönemlerinde görev alma.
- Kayıtlı kişilerin **izlem çağrıları** (telefon, SMS ile randevu ve aşı hatırlatma).

---

3. AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ (HEMŞİRE/EBE) GÖREVLERİ

ASM'de birlikte çalışacağın hemşire ya da ebenin görevlerini bilmek, hem bu beceride hem de profesyonel rolünü anlatmada işine yarar:

1. Aile hekiminin verdiği görevleri yapmak, poliklinik hizmetlerine yardım etmek.
2. **Gebe, lohusa, bebek, çocuk, ergen, yaşlı ve kronik hasta izlemlerini** yapmak ya da izlemlere yardım etmek.
3. **Aşı** uygulamalarını yapmak, aşı takibini sürdürmek, **soğuk zinciri** korumak (buzdolabı ısı takibi), aşı stoklarını izlemek.
4. Enjeksiyon, pansuman, kan alma, EKG gibi **tıbbi işlemleri** yapmak.
5. **Ev ziyaretleri** yapmak.
6. **Sağlık eğitimi ve danışmanlık** vermek.
7. **Kayıtları** tutmak, istatistik ve bildirimleri yapmak.
8. Tıbbi malzeme, ilaç ve aşı **stoklarını** takip etmek; **tıbbi atık yönetimini** sağlamak.
9. Kanser tarama işlemlerini yapmak ve yönlendirmek.
10. Kayıtlı kişileri izlem ve aşılar için **çağırmak**, izlemleri aksayanları takip etmek.

Hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları **6283 sayılı Hemşirelik Kanunu** ve **Hemşirelik Yönetmeliği (2011)** ile tanımlanmıştır; halk sağlığı hemşiresi toplumun sağlık gereksinimlerini belirleme, koruyucu hizmetler, sağlık eğitimi, ev ziyaretleri, izlemler, aşılama, okul ve işyeri sağlığı, kayıt ve bildirim gibi görevler üstlenir.

---

4. HİZMET VERİLEN TOPLUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Hangi verileri toplamalısın?

Bu bilgiler ASM'nin bilgi sistemi raporlarından, izlem listelerinden, rehber hemşireden ve aile hekiminden öğrenilir. **Kişisel bilgi değil, sayısal özet** toplanır. Toplaman gereken veriler:

Genel nüfus bilgileri:

- ASM'deki birim sayısı ve **birimine (ya da ASM'ye) kayıtlı toplam nüfus**
- **Kadın ve erkek** sayıları
- **Yaş gruplarına göre dağılım** (0–1, 1–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–64, 65 ve üzeri; varsa 5'er yıllık gruplar)

Hedef gruplar (beceri listesinde özellikle sayılanlar):

- **0–1 yaş bebek sayısı** (bebek izlemi ve aşı hedef nüfusu)
- **1–4 (ya da 1–5) yaş çocuk sayısı**
- **Okul çağı (5–14 yaş) ve ergen (10–19 yaş) sayısı**
- **15–49 yaş kadın sayısı** (doğurganlık çağı; aile planlaması ve üreme sağlığı hedef nüfusu)
- **İzlemdeki gebe sayısı** ve bunların içinde **riskli gebe** sayısı
- **Lohusa sayısı** (son 42 gün içinde doğum yapanlar)
- **65 yaş ve üzeri yaşlı sayısı** (ve 85 yaş üstü)
- **Kronik hastalığı olan birey sayısı** – hastalıklara göre: hipertansiyon, diyabet, KOAH ve astım, kalp-damar hastalığı, obezite, kronik böbrek hastalığı, kanser
- **Engelli ve yatağa bağımlı birey sayısı**; evde sağlık hizmeti alanlar
- **Göçmen ve geçici koruma altındaki** kişilerin sayısı (varsa)

Kanser tarama hedef nüfusları:

- 30–65 yaş kadın (serviks), 40–69 yaş kadın (meme), 50–70 yaş kadın ve erkek (kolorektal); bunların ne kadarının taramasının güncel olduğu

Hizmet göstergeleri:

- Aşılama oranları (bebek aşıları, KKK gibi)
- İzlem kapsamları (gebe, bebek, çocuk izlemlerinin zamanında yapılma oranı)
- Son bir yıldaki doğum ve ölüm sayıları, varsa bebek ölümleri

4.2 Nüfus piramidi ve yorumlanması

Yaş-cinsiyet dağılımı **nüfus piramidi** ile gösterilir: dikey eksende yaş grupları (en altta en küçük yaş), yatay eksende solda erkek, sağda kadın nüfus yer alır.

- **Geniş tabanlı (üçgen) piramit:** Doğurganlık yüksek, nüfus genç. ASM'de **ana-çocuk sağlığı, aşılama, aile planlaması** öncelikli hizmetlerdir.
- **Tabanı daralmaya başlamış (arı kovanı ya da silindir) piramit:** Doğurganlık düşüyor, nüfus yaşlanıyor. **Kronik hastalık ve yaşlı sağlığı** hizmetleri önem kazanır.
- **Tabanı dar, üstü geniş (ters) piramit:** Yaşlı nüfus belirgin biçimde fazla, doğurganlık çok düşük.

Türkiye'de doğurganlık son yıllarda belirgin olarak düşmüştür (TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2024'te yaklaşık 1,48; nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken düzey 2,1'dir) ve 65 yaş üstü nüfusun oranı artmaktadır (yüzde 10'un üzerinde). Yani Türkiye'nin nüfus piramidi giderek tabanı daralan bir yapıya dönüşmektedir. **Güncel değerleri TÜİK'ten kontrol et** ve ASM'nin verilerini Türkiye ortalamasıyla karşılaştır.

4.3 Sağlık göstergeleri ve formülleri

Değerlendirmede "Bebek ölüm hızı nasıl hesaplanır?" gibi sorular gelebilir. Bu göstergelerde en sık yapılan hata **paydayı karıştırmak**tır.

Doğumla ilgili göstergeler:

- **Kaba doğum hızı** = Bir yıldaki canlı doğum sayısı ÷ aynı yılın ortasındaki nüfus × 1000
- **Genel doğurganlık hızı** = Bir yıldaki canlı doğum sayısı ÷ 15–49 yaş kadın nüfusu × 1000
- **Toplam doğurganlık hızı:** Bir kadının doğurganlık çağı boyunca (15–49 yaş) doğurması beklenen ortalama çocuk sayısı (yaşa özel doğurganlık hızlarından hesaplanır).

Ölümle ilgili göstergeler:

- **Kaba ölüm hızı** = Bir yıldaki ölüm sayısı ÷ yıl ortası nüfus × 1000
- **Yaşa özel ölüm hızı** = Bir yaş grubundaki ölüm sayısı ÷ o yaş grubunun nüfusu × 1000
- **Bebek ölüm hızı** = Bir yılda 1 yaşından önce ölen bebek sayısı ÷ **aynı yıldaki canlı doğum sayısı** × 1000
- **Neonatal (yenidoğan) ölüm hızı** = 0–27 günlükken ölen bebek sayısı ÷ canlı doğum × 1000
- **Erken neonatal ölüm hızı** = İlk 7 günde (0–6 gün) ölen bebek sayısı ÷ canlı doğum × 1000
- **Postneonatal ölüm hızı** = 28–364 günlükken ölen bebek sayısı ÷ canlı doğum × 1000
- **Perinatal ölüm hızı** = (Ölü doğumlar [22. hafta ve sonrası ya da 500 g ve üzeri] + ilk 7 gün içindeki bebek ölümleri) ÷ (ölü doğum + canlı doğum) × 1000
- **5 yaş altı ölüm hızı** = 5 yaşından önce ölen çocuk sayısı ÷ canlı doğum × 1000
- **Anne ölüm oranı** = Gebelik, doğum ya da doğumdan sonraki 42 gün içinde gebelikle ilişkili nedenlerle ölen kadın sayısı ÷ canlı doğum sayısı × **100.000**

Nüfus yapısıyla ilgili göstergeler:

- **Bağımlı nüfus oranı** = (0–14 yaş nüfus + 65 yaş ve üzeri nüfus) ÷ 15–64 yaş nüfus × 100
- **Yaşlı bağımlılık oranı** = 65 yaş ve üzeri nüfus ÷ 15–64 yaş nüfus × 100
- **Yaşlı nüfus oranı** = 65 yaş ve üzeri nüfus ÷ toplam nüfus × 100

Hastalık göstergeleri:

- **İnsidans hızı** = Belirli bir dönemde ortaya çıkan **yeni** olgu sayısı ÷ o dönemde risk altındaki nüfus × 1000 (ya da 100.000). Hastalığa **yakalanma** riskini gösterir.
- **Prevalans hızı** = Belirli bir anda (ya da dönemde) var olan **tüm (eski ve yeni)** olguların sayısı ÷ toplam nüfus × 100 (ya da 1000). Hastalığın toplumdaki **yükünü** gösterir. Örneğin "ASM'ye kayıtlı 18 yaş üstü nüfusta hipertansiyon prevalansı" kronik hastalık yükünü anlatır.

Hizmet göstergeleri:

- **Aşılama hızı (oranı)** = Aşılanan kişi sayısı ÷ hedef nüfus × 100
- **İzlem kapsamı** = İzlenen kişi sayısı ÷ hedef nüfus × 100

- **Ortalama izlem sayısı** = Toplam izlem sayısı ÷ izlenen kişi sayısı
- **Tarama kapsamı** = Taranan kişi sayısı ÷ tarama hedef nüfusu × 100

Örnek hesaplamalar:

- ASM bölgesinde bir yılda **410 canlı doğum** olmuş ve 1 yaşından önce **4 bebek** ölmüşse: Bebek ölüm hızı = 4 ÷ 410 × 1000 ≈ **9,8 (binde)**.
- Birime kayıtlı 3.450 kişinin **415'i 65 yaş ve üzerindeyse**: Yaşlı nüfus oranı = 415 ÷ 3.450 × 100 ≈ **%12**.
- 0–14 yaş 690, 15–64 yaş 2.345, 65+ 415 kişi ise: Bağımlı nüfus oranı = (690 + 415) ÷ 2.345 × 100 ≈ **%47** (her 100 çalışma çağındaki kişiye yaklaşık 47 bağımlı kişi düşer).
- 18 yaş üstü 2.600 kişinin 410'unda hipertansiyon kayıtlıysa: Hipertansiyon prevalansı ≈ 410 ÷ 2.600 × 100 ≈ **%15,8**.

Bebek ölüm hızı neden bu kadar önemlidir? Bebek ölüm hızı; annenin sağlığı ve beslenmesi, gebe ve bebek izlemlerinin niteliği, aşılama, emzirme, çevre sağlığı (su, temizlik), eğitim ve gelir düzeyi gibi birçok etkenin ortak sonucudur. Bu yüzden bir toplumun **sosyoekonomik gelişmişliğinin ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin en duyarlı göstergelerinden biri** olarak kabul edilir.

4.4 Verileri nasıl sunarsın? – Örnek konuşma

Değerlendiren kişi "ASM'nizin nüfusunu anlatır mısın?" diye sorduğunda şu yapıda bir cevap ver: **toplam nüfus → cinsiyet → yaş yapısı → hedef gruplar → kronik hastalık yükü → bu verilerin ASM hizmetlerine yansıması.**

> "Çalıştığım birimde 3.450 kayıtlı kişi var; yaklaşık %51'i kadın. Nüfusun yaklaşık %20'si 0–14 yaşında, %12'si 65 yaş ve üzerinde; yani yaşlı nüfus oranımız Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Şu anda 0–1 yaşta 38 bebek ve 1–5 yaş arasında 190 çocuk izliyoruz. 15–49 yaş arasında 870 kadın var; bunlardan 29'u gebe ve 4'ü riskli gebe olarak izleniyor; 6 lohusamız var. Kronik hastalık yükümüz yüksek: 410 hipertansif ve 230 diyabetik birey kayıtlı; 18 yaş üstü nüfusta hipertansiyon prevalansı yaklaşık %16. Kanser taramalarında 50–70 yaş grubunda gaitada gizli kan testi kapsamımız düşük. Bu yüzden birimimizde aşı ve bebek-gebe izlemlerinin yanında yaşlı ve kronik hasta izlemleri ile kolorektal ve meme kanseri taraması öncelikli hizmetlerdir. Ben de eğitimlerimi hipertansiyonda tuz kısıtlaması, diyabette ayak bakımı ve kanser taramaları üzerine planladım."

Bu konuşma hem demografik özellikleri anlatır hem de **verileri yorumlayıp hizmetlerle ilişkilendirdiğini** gösterir; "beklenti düzeyinin" üstünde bir puan için bu ilişkilendirme önemlidir.

---

5. ASM'NİN FİZİKİ YAPISI VE BİRİMLERİ

ASM'yi gezerken aşağıdakileri gözlemleyip anlatabilmelisin:

- **Bekleme salonu:** Oturma alanları, eğitim için kullanılabilecek alan, duyuru panoları, broşür standı.
- **Muayene odaları.**
- **Aşı odası:** Aşı buzdolabı, **ısı takip çizelgesi**, soğuk taşıma kabı ve buz aküleri, **anafilaksi seti**, aşı takvimi afişi, kesici-delici atık kutusu.
- **Müdahale/enjeksiyon odası:** Enjeksiyon, pansuman, kan alma malzemeleri, acil müdahale seti.
- **Gebe-bebek izlem odası:** Bebek tartısı, boy ölçme tahtası, mezura, persentil eğrileri, Doppler, gebe izlem formları.
- **Kadın sağlığı ve aile planlaması odası:** Jinekolojik masa, spekulumlar, HPV-smear malzemeleri, aile planlaması yöntemleri.
- **Laboratuvar/örnek alma bölümü.**
- **Tıbbi atık alanı:** Kırmızı tıbbi atık torbaları ve kutuları, kesici-delici atık kutuları; evsel atıklar için siyah, geri dönüşüm için mavi torbalar.
- **Güvenlik ve erişilebilirlik:** El hijyeni noktaları, yangın söndürücü, acil çıkış, engelli rampası ve tuvaleti.

---

6. KENDİNİ TEST ET

1. Sağlık hizmetlerinin basamaklarını ve birinci basamak kurumlarını say.
2. Alma-Ata Bildirgesi'nin hedefi ve temel ilkeleri nelerdir?
3. Türkiye'de aile hekimliğine geçiş hangi yıllarda, nasıl oldu?
4. Bir aile hekimliği birimi kimlerden oluşur? Aile sağlığı elemanı olarak kimler çalışabilir?
5. ASM'nin verdiği hizmetlerden en az 15'ini gruplar halinde say.
6. Aile sağlığı elemanının görevleri nelerdir?
7. Çalıştığın ASM'nin kayıtlı nüfusu, gebe, bebek, 65 yaş üstü ve kronik hastalıklı birey sayıları nedir?
8. Geniş tabanlı ve tabanı daralan nüfus piramitleri ASM'nin hizmet önceliklerini nasıl etkiler?
9. Bebek ölüm hızının, anne ölüm oranının ve perinatal ölüm hızının formüllerini yaz; paydaları ve katsayıları nedir?
10. Prevalans ile insidans arasındaki fark nedir? Hipertansiyon için hangisini kullanırsın?
11. Bağımlı nüfus oranı nasıl hesaplanır, ne anlama gelir?
12. Bebek ölüm hızı neden toplumun gelişmişliğinin önemli bir göstergesidir?
13. ASM'nin aşı odasında neler bulunmalıdır?